

TEMA 3.32 • OBSTETRICIA

Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales

PERFIL EUNACOM 1.03.32
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales

Manejo General

- **Alto riesgo obstétrico** (controles más frecuentes)
- **Corticoides antenatales** — alto riesgo de parto prematuro
- **Aspirina 81–100 mg/día** — factor de riesgo alto para preeclampsia (gemelar es FR de alto riesgo)
- **Ecografías frecuentes** para monitorear complicaciones

Momento de Interrupción

TABLA 3.32.1: TIPO VS INTERRUPCIÓN	
TIPO	INTERRUPTIÓN
Bicorial	38 semanas
Monocorial–biamniótico	36 semanas
Monocorial–monoamniótico	32–34 semanas (hospitalización desde las 26 sem)

Vía de Parto

Determinada por la presentación del GEMELO 1 (el que está más bajo):

TABLA 3.32.2: GEMELO 1 VS GEMELO 2		
GEMELO 1	GEMELO 2	VÍA
Cefálica	Cefálica o No cefálica	Vaginal
No cefálica	Cualquiera	Cesárea
Monoamniótico	—	Cesárea siempre

NOTA CLÍNICA

La presentación del gemelo 2 no determina la vía si el gemelo 1 es cefálico. Si el gemelo 1 ya nació, el canal del parto está probado y el gemelo 2 puede nacer en podálica o con versión externa. En la práctica en Chile, la tendencia es a la cesárea en la mayoría de los gemelares.

Complicaciones Generales (todos los gemelares)

TABLA 3.32.3: COMPLICACIÓN VS DETALLE	
COMPLICACIÓN	DETALLE
Parto prematuro	Más frecuente — útero sobredistendido
RCIU	Competencia por nutrición
Gemelos discordantes	Diferencia de peso > 25% entre gemelos
Preeclampsia	Puede ocurrir < 20 semanas (excepción a la regla)
Malformaciones	Compresión de un gemelo sobre el otro
Muerte de un gemelo	Ver capítulo específico

Complicaciones maternas

- Anemia
- Hiperemesis gravídica
- **Atonía uterina** (útero sobredistendido → mayor riesgo de hemorragia puerperal)
- Hígado graso agudo del embarazo
- Edema pulmonar agudo
- Síndrome hipertensivo del embarazo

Complicaciones Exclusivas de Monocoriales

(Ver capítulo 34 para detalle)

- **STFF** (síndrome de transfusión feto-fetal)
- **TAPS** (síndrome de anemia-policitemia)
- **Secuencia TRAP** (gemelo acardio)
- **Entrelazamiento de cordones** (solo monoamnióticos)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Manejo General
- Momento de Interrupción
- Vía de Parto
- Complicaciones Generales (todos los gemelares)
- Complicaciones maternas
- Complicaciones Exclusivas de Monocoriales
- Alto riesgo obstétrico

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EMBARAZO GEMELAR — MANEJO Y COMPLICACIONES GENERALES)**PREGUNTA 1**

Respecto a Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Embarazo Gemelar — Manejo y Complicaciones Generales. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: EMBARAZO GEMELAR — MANEJO Y COMPLICACIONES GENERALES

:::note La presentación del gemelo 2 no determina la vía si el gemelo 1 es cefálico. Si el gemelo 1 ya nació, el canal del parto está probado y el gemelo 2 puede nacer en podálica o con versión externa.